

Fecha Última Actualización: 01-07-2022 22:38:18

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Juana Patricia Viveros Cáceres
Edad : 65a 5m 1d
Dirección : Azores Sur 678

Rut : 8.180.354-4
Fecha Nacto: 31/01/1957
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 2211659
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 8295 8737

N° Epicrisis
311535

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Utac/ Utinx

Fecha Ingreso : 09/06/2022 15:04

Días Estadía: 22

Unidad de Egreso : Utac/ Utinx

Fecha Egreso : 01/07/2022 22:07

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Tumor intracraneano

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

De Base De Cráneo, Resección De Tumores Y/O Quistes Y/O Cavernoma - 14/06/2022 08:45 - Daniel Soto Sepulveda
Angiografía Cerebral Digital Por Cateterización (Incluye Proc. Radiológico, Medio De Contraste E Insumos) - 13/06/2022 08:30
- Juan Carlos Zamora Joglar

Epidemiología

Resumen Clínico

FI CASR: 09/06/2022
FI UP: 14/06/2022
FI UTAC: 16/06/2022

Paciente diestra, mRs 2, con antecedentes de:

Morbidos: No
Alergias: Paracetamol
Quirúrgicos: Colecistectomía, exéresis reciente de tumor frontal derecho (meningioma)
Habitos: No fuma, no bebe alcohol, no consume drogas
Social: Vive con su esposo e hija
Escolaridad: 4to medio
Ocupacion: Dueña de casa

Paciente con antecedentes descritos fue traída por familiar al servicio de urgencias de CASR el 09/06/2022 por cuadro clínico de algunos meses de evolución caracterizado por deterioro cognitivo al que que el 08/06/2022 se sumo hemiparesia izquierda, desorientación y somnolencia. Trajo tomografía (TC) de encéfalo del 28/05/2022 que objetivo lesión extraaxial frontal derecha de aproximadamente 6 x 6 cm con efecto de masa y edema perilesional. Al examen físico se objetivó que la paciente seguía órdenes simples, emitía lenguaje, desorientada en tiempo y espacio, fuerza extremidad superior izquierda M2 y extremidad inferior izquierda M1.

En ese contexto se hospitalizó e ingresó a UTI neuroquirúrgica a la espera de cirugía.

El día 9/6/22 se realizó TC encefalo en la que impresionó extensa lesión frontal derecha, extraaxial, con edema perilesional, hernia transfalcina y efecto de masa. Se inició corticoides y fenitoína.

Se solicito RMN de encéfalo, que evidenció:

Voluminosa lesión tumoral redondeada de localización extraaxial frontal anterior derecha que alcanza aproximadamente 7,8 x

Fecha Epicrisis : 01/07/2022 22:38

Página 1 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 15:50

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 01-07-2022 22:38:18

Página 2 de 3

6,4 x 6,1 cm en los ejes antero-posterior, transversal y céfalo-caudal, respectivamente. Exhibe base dural frontal anterior parasagital derecha, donde determina hiperostosis. Presenta señal heterogénea, con algunas áreas necróticas/quísticas. Gran parte de la lesión corresponde a componente sólido que capta intensamente el contraste con el uso de gadolinio. Determina significativo efecto de masa caracterizado por disminución de la amplitud del espacio subaracnoideo adyacente, también del VL correspondiente, además de menor amplitud del tercer ventrículo y de la porción corporal y cuerno frontal del VL opuesto. Importante desplazamiento hacia posterior y hacia la izquierda del parénquima frontal derecho y hacia la izquierda del parénquima frontal izquierdo, con desviación de las estructuras de la línea media a izquierda, estimado en aproximadamente 21 mm a nivel del septum pellucidum. Se acompaña de herniación subfalcina y avance uncal. Se delimita plano de clivaje con el parénquima frontal adyacente, el que exhibe alteración de su señal T2/FLAIR.

Dilatación del atrio y cuernos occipital y temporal del VL izquierdo, con signos de edema transependimario asociado. Cuarto ventrículo y restante espacio subaracnoideo de amplitud normal.

No se identifican otras lesiones parenquimatosas.

Impresión:

Voluminosa lesión extraaxial frontal anterior derecha de aspecto tumoral, con significativo efecto de masa, y caracteres sugerentes de un meningioma.

El 13/06/2022 se realizó angiografía, en donde en protocolo operatorio se objetivó: se realizó angiografía, sin embargo no fue posible embolizar, frustra. Se confirma blush tumoral frontal derecho alimentado principalmente por arteria meníngea anterior y en menor medida en su aspecto medial, por meníngea media izquierda. Existe anastomosis de AMA con rama de arteria temporal superficial derecha. No se visualiza arteria meníngea media derecha. La inyección de ACI derecha muestra gran desplazamiento de estructuras vasculares por efecto de masa del tumor.

El 14/06 ingresó a pabellón para exéresis tumoral total por craneotomía. Procedimiento realizado sin incidentes. Ingresó a UCI en el postoperatorio inmediato. TC de cerebro post operatorio sin complicaciones.

Luego se traslada a Intermedio y posteriormente a sala dada su buena evolución. Por traqueobronquitis cursó tratamiento antibiótico con tazonam por 10 días con resultado favorable.

Se mantuvo con anticonvulsivantes orales y con corticoides EV con disminución progre siva de la dosis hasta suspender.

En cuando a la rehabilitación, mantiene régimen sin restricción y seguimiento por FNA. En cuando a lo kinesiológico, logra transición a Bípedo con máxima asistencia, no logra extensión completa de EEII, requiere de asistencia completa para poder mantener el bípedo. (x 5 repeticiones.)

Por buena evolución y haber completado objetivos de su hospitalización ,se decide el alta médica.

Diagnóstico de Egreso

Tumor Frontal Derecho -

Condición de Egreso

Traslado

Egreso con Catéter Doble J:NO

Estable.

Plan Post Alta

Reposo relativo

Régimen liviano

Kinesiología 1 vez al día por 4 semanas

Mantener medicamentos de uso crónico habitual.

Fenitoina 100mg AM y 150mg PM VO

Insulina NPH 20U AM y 10U PM

Control con Dr. Daniel Soto en 2 semanas, solicitar hora directamente.

Consultar en S Urgencia si presenta sospecha de complicación.

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Fecha Epicrisis : 01/07/2022 22:38

Página 2 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 15:50

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Controles

INTERNO

Pablo López Lobos
Becado/Residente

Marcos Ignacio Ramirez Palma
Médico Tratante (Staff)